
QCM • CONCOURS

Concours de recrutement des IDE 2ème Grade - Session du 03 Mars 2012

Technicien de Radiologie

Specialite : Technicien de Radiologie

Annee : 2012

16 questions

Questions

1 Parmi les positions suivantes, laquelle correspond à celle du patient dans l'incidence du rachis lombaire en oblique anté/postérieur :

- | | |
|---|--|
| A | Malade debout, le coté opposé s'écarte du plan d'appui en faisant un angle 70° |
| B | Malade debout, le côté opposé s'écarte du plan d'appui en faisant un angle de 30° à 45° |
| C | Malade debout, le côté à radiographier s'écarte du plan d'appui en faisant un angle de 30° à 45° |
| D | Malade debout, le côté à radiographier s'écarte du plan d'appui en faisant un angle de 70° |

2 Parmi les critères de réussite suivants, lequel ne correspond pas au cliché de l'incidence de face du rachis cervical :

- | | |
|---|---|
| A | Position médiane de la ligne des épineuses |
| B | Position médiane de la trachée |
| C | L'axe sagittal passe le milieu de l'odontoïde et de l'épine de l'axis |
| D | Position symétrique du maxillaire inférieur |
| E | Bonne visibilité des espaces intervertébraux |

3 Lequel des centrages correspond à celui de l'incidence du coccyx de face en décubitus :

- | | |
|---|--|
| A | R.D incliné de 20° à 30° vers les pieds sur la symphyse pubienne |
| B | R.D incliné de 20° à 30° vers les têtes sur la symphyse pubienne |
| C | R.D Incliné de 10° à 20° vers la tête sur la symphyse pubienne |
| D | R.D incliné de 10° à 20° vers les pieds sur la symphyse pubienne |

4 Pour dégager les arcs postérieurs des côtes, le patient prend la position :

- A Face en antéropostérieure
- B Oblique en antéro-postérieur
- C Face en postéro-antérieur
- D Oblique en postéro-antérieur

5 Pour dégager les arcs moyens des côtes, le patient prend la position :

- A Face en antéro-postérieur
- B Oblique en antéro-postérieur
- C Face en postéro-antérieur
- D Oblique en postéro-antérieur

6 On désigne par les fausses côtes :

- A Les 6 ème, 7 ème, 8 ème, 9 ème, et 10 ème côtes
- B Les 7 ème, 8 ème, et 9 ème côtes
- C Les 7 ème, 8 ème, 9 ème, 10 ème et 11 ème côtes
- D La 11ème et 12ème côtes

7 Pour explorer l'omoplate de face :

- A ON soulève l'épaule non à radiographier d'un angle de 20°
- B On soulève l'épaule à radiographier d'un angle de 45°
- C On soulève l'épaule à radiographier d'un angle de 20°
- D On soulève l'épaule non à radiographier d'un angle de 45°

8 Pour explorer le bec Olécrânien, on centre :

- A 3 à 4cm au dessous de l'apophyse coronoïde
- B 3 à 4cm au dessus de la pointe de l'olécrane
- C Sur la pointe de l'olécrane
- D 3 à 4cm au dessous de la pointe de l'olécrane

9 Lesquels des critères de réussite suivants correspondent aux critères de réussite de l'incidence de coude de face :

- A Sommet de l'olécrane au milieu de la fossette coronoïdienne
- B L'interligne cubito-humérale visible
- C Sommet de l'olécrane au milieu de la fossette olécrânienne
- D L'interligne condyle- tête radiale visible

10 Pour dégager l'articulation radio-scaphoïdienne, on choisie la/ les incidence(s) radiologique(s) suivantes :

- A Schreeck 1
- B Schreeck 2
- C Poignet de profil
- D Oblique interne de poignet

11 Une épaule traumatisée nécessite :

- A Face de l'épaule en rotation externe
- B Face de l'épaule en rotation neutre
- C Profil de l'épaule de haut en bas
- D Incidence de Bernajeau

12 Parmi les incidences radiologiques suivantes, lesquelles faut 'il réaliser chez un patient présentant une fracture de l'apophyse coronoïde du cubitus :

A	Profil du coude main en demi pronation
B	Profil du coude main en pronation
C	Face du coude main en supination
D	Face du coude main en pronation

13 Le cliché pulmonaire en incidence de Muller (décubitus latéral) :

A	Est moins irradiant
B	Réalisé chez les patients en mauvais état général
C	Mobiliser un épanchement pleural
D	Facilite le diagnostic de la tuberculose
E	Nécessite un portique vertical

! Page jump in original numbering from Q16 directly to Q21. Sequential mapping maintained here.

14 Sur le cliché pulmonaire de face en expiration forcée :

A	Les clavicules sont asymétriques
B	Les coupes diaphragmatiques sont hautes
C	Les bases pulmonaires sont surexposées
D	Le médiastin est élargi
E	Voir un pneumothorax

15 Le sulfate de baryum :

A	Contre indiqué en cas de suspicion de perforation
B	Toujours associé à la gastrografine
C	Contre indiqué en cas d'occlusion par invagination intestinale chez le nourrisson
D	Ne nécessite pas de préparation digestive
E	Occasionne des allergies

16 La gastrografine :

A	Est utilisée exclusivement par voie orale
B	Son Z est inférieur à celui du baryum
C	Elle peut provoquer des phénomènes de diarrhées
D	Elle est inoffensive pour le péritoine
E	Peut être associée au sulfate de baryum